Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

ICF

classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute

Chiara Balerna, Michela Luraschi, Donatella Oggier-Fusi, Piercarla Reposo
Modulo: Percorsi nelle disabilità 2026

17 MARZO 2026

PROGRAMMA DELLA LEZIONE

- Presentazione slide con esercitazioni
- pausa
- Seminario

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

. Conoscere l'ICF ed i **cambiamenti** apportati da esso.

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

- Conoscere la **struttura** dell'ICF
- Conoscere il **linguaggio** dell'ICF

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

. Comprendere le **implicazioni professionali** nell'uso dell'ICF

. **Approcciarsi** allo strumento praticamente

OBIETTIVI DELLA LEZIONE

- Sviluppare consapevolezza sulla propria responsabilità educativa

ICF PERCHE' ?

strumento internazionale

definizione disabilità

valutazione globale

PROGETTAZIONE

presa a carico

linguaggio condiviso

ICF cos'è ?

È la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute fa parte della famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'OMS

ICF cos'è ?

È uno strumento che analizza e descrive la disabilità *come condizione umana che tutti possono sperimentare*

ICF cos'è ?

L'ICF traduce i principi universali sanciti nella Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità (NewYork, 13 dicembre 2006):

***Per persone con disabilità** si intendono coloro che presentano durature **MENOMAZIONI FISICHE, MENTALI, INTELLETTUALI O SENSORIALI** che*
***in interazione con BARRIERE** di diversa natura possono ostacolare la loro*
*piena ed effettiva **PARTECIPAZIONE** nella società su base di uguaglianza con gli altri (art.1).*

si evolve inoltre a partire dal concetto di salute promossa dall'OMS

"La salute è una componente fondamentale della nostra vita. L'Organizzazione mondiale della sanità la definisce «**uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplice assenza di malattia** (...)"

https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/temi/salute-e-promozione-della-salute.html

La salute non riguarda solo alcune parti di un individuo (fegato, polmoni..) **ma è uno stato di piena forma dell'intera persona;**

si evolve inoltre a partire dal concetto di salute promosso dall'OMS

La salute è essenzialmente legata al **funzionamento umano a tutti i livelli** (**biologico, personale e sociale**);

La salute non può essere separata dal contesto o ambiente in cui la persona vive. La salute quindi **interagisce con l'ambiente e l'ambiente interagisce con essa**;

La salute **è una risorsa** per la vita quotidiana e non lo scopo dell'esistenza. Si tratta di un **concetto positivo** che valorizza le risorse sociali e personali, oltre alle capacità fisiche.

ICF cos'è ?

appartiene alla famiglia delle classificazioni internazionali ed è stato realizzato dall'OMS.

È uno strumento utilizzato internazionalmente per descrivere, misurare e classificare salute e disabilità.

Tramite esso è possibile ricavare informazioni strutturate sulla salute delle persone

A livello di: strutture dell'organismo, funzioni, attività, partecipazione alle situazioni di vita.

ICF cos'è ?

Esistono **due versioni** dell'ICF, quello classico e quello con dicitura ICF-CY (ovvero Children and Youth). Una prima traduzione italiana è del 2002 relativa alla prima edizione dell'OMS del 2001.

Inoltre esiste una versione breve, con livelli di classificazione ridotti

https://docenti.unimc.it/catia.giaconi/teaching/2023/28852/files/icf-versione-breve-1

Cambio di PARADIGMA

da modelli medici e riabilitativi (DSM- ICD)
a modelli BIO-PSICO-SOCIALI (ICF- PPH)

la persona è considerata nella sua completezza ed in relazione con il CONTESTO

pensiamo

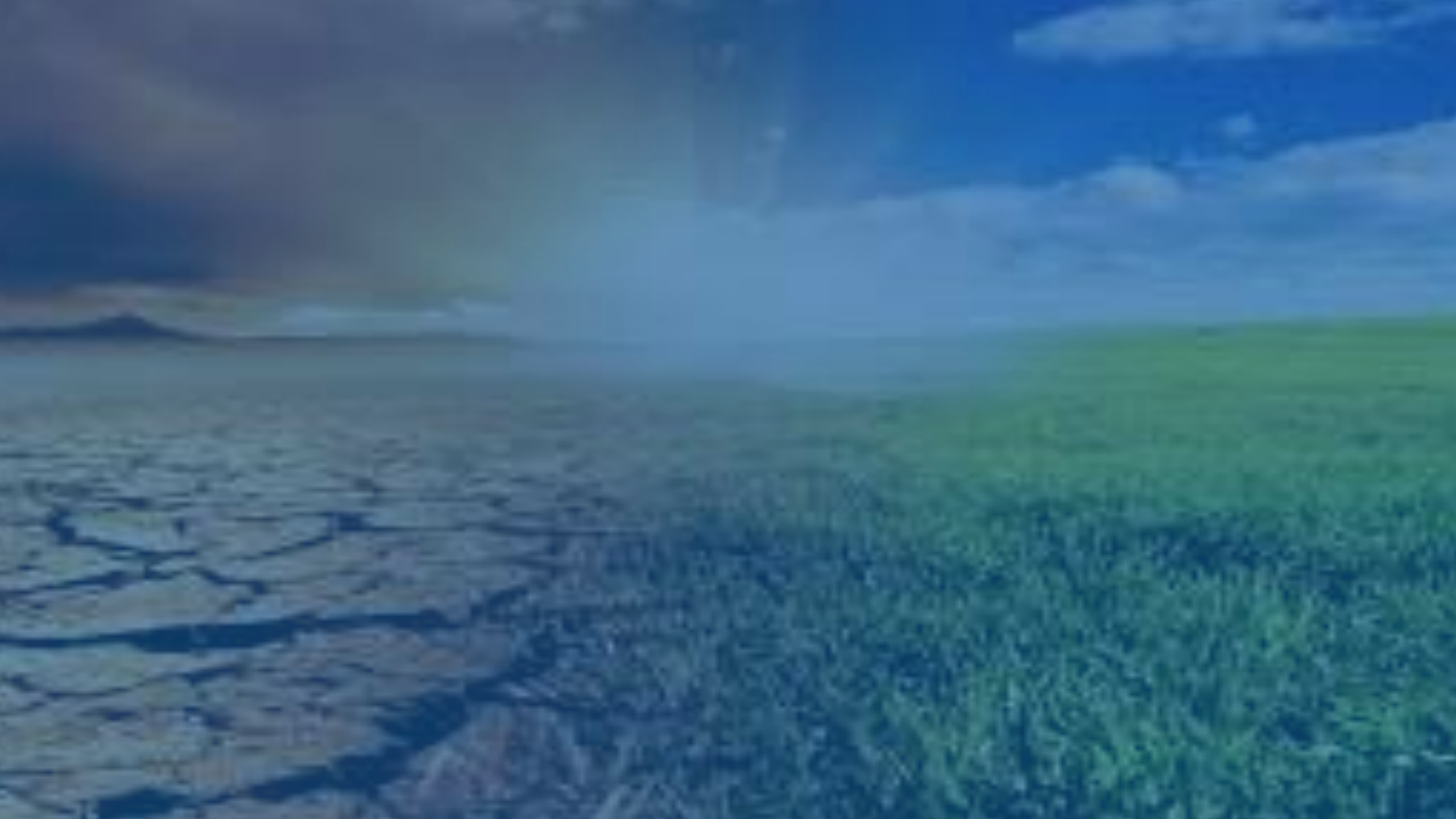
- Dividi un foglio in 2 parti
- Fai memoria di un momento in cui ti sei sentito in difficoltà, scrivilo a sinistra
- Fai memoria di un momento in cui ti sei sentito in gamba, scrivilo a destra

non ok	ok

pensiamo

PARAGONALI
Eri in forma nel primo ? E nel secondo?
Come ti sentivi e cosa pensavi nel primo? E nel secondo?
Chi c'era intorno a te e com'era il luogo nel primo? E nel secondo? Disabilità? Salute ?

non ok	ok
Condizioni di salute	Condizioni di salute
Fattori personali	Fattori personali
Fattori ambientali	Fattori ambientali



Cambio di PARADIGMA

Si analizza la vita delle persone, dei modi con cui esse **convivono** con le loro patologie e le **affrontano** in diversi **contesti**.

Cambio di PARADIGMA

La disabilità è definita dalle relazioni che intercorrono tra le condizioni della persona e i fattori contestuali.

Cambio di PARADIGMA

La persona ha delle caratteristiche che sono influenzate da fattori interni e/o esterni, caratteristiche e fattori ne definiscono il funzionamento e la partecipazione sociale.

L'ICF è un modello *multidisciplinare* e *multidimensionale* integra tre dimensioni:

- biologica (condizioni di salute)
- psichica (fattori personali)
- sociale (fattori ambientali)

Cambio di PARADIGMA

L'ICF è un modello *interattivo* che considera le **relazioni** tra:
funzioni e strutture corporee,
attività, partecipazione ed ambiente.

Cambio di PARADIGMA

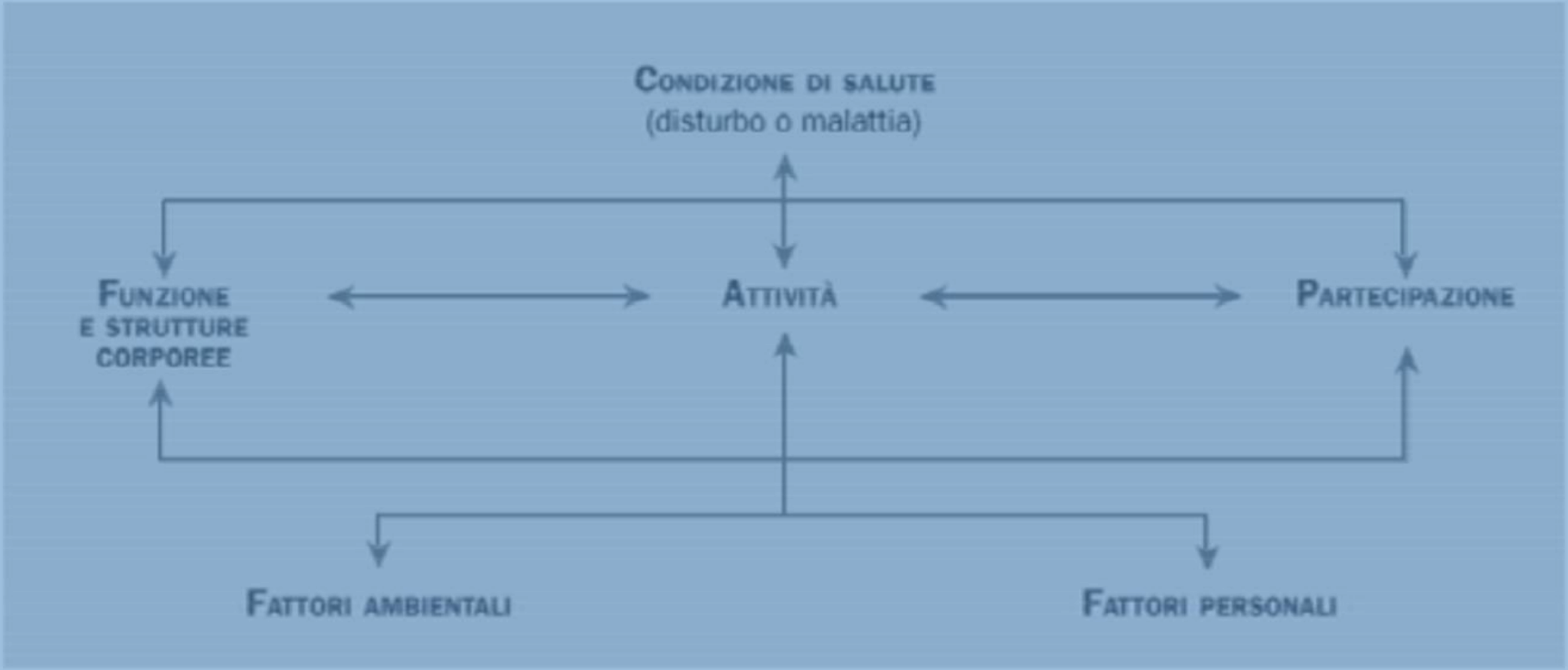


Fig. 5.1 Interazioni tra le componenti dell'ICF.

Cambio di PARADIGMA

Con l'ICF cambia il concetto di disabilità

In questa classificazione si considerano:

i fattori biomedici

i fattori ambientali

la partecipazione sociale

L'ICF è diverso dal modello medico perché:

Modello medico	ICF
Si concentra sulla malattia	Si concentra sul funzionamento
Spiega il deficit	Analizza l'interazione persona-ambiente
È lineare e causale	È sistemico e multidimensionale
Guarda "ciò che manca"	Guarda "ciò che è possibile"

Cambio di PARADIGMA

Questa differenza è fondamentale perché permette una valutazione più completa, **inclusiva** e orientata alla **partecipazione**, non alla patologia

Cambio di PARDIGMA

L'ICF non spiega "che cosa non va", ma "**che cosa serve per funzionare meglio**"

Il modello medico risponde alla domanda:

"Qual è il problema biologico?"

L'ICF risponde a una domanda molto più utile nei contesti educativi, sociali:

"Quali condizioni permettono alla persona di partecipare e funzionare al meglio?"

Questo sposta l'attenzione dalla diagnosi alla progettazione di interventi concreti.

-

La struttura dell'ICF

«Le informazioni fornite dall'ICF sono una descrizione delle situazioni che riguardano il funzionamento umano e le sue restrizioni, e la classificazione serve da modello di riferimento per l'organizzazione delle informazioni...»

introduzione ICF

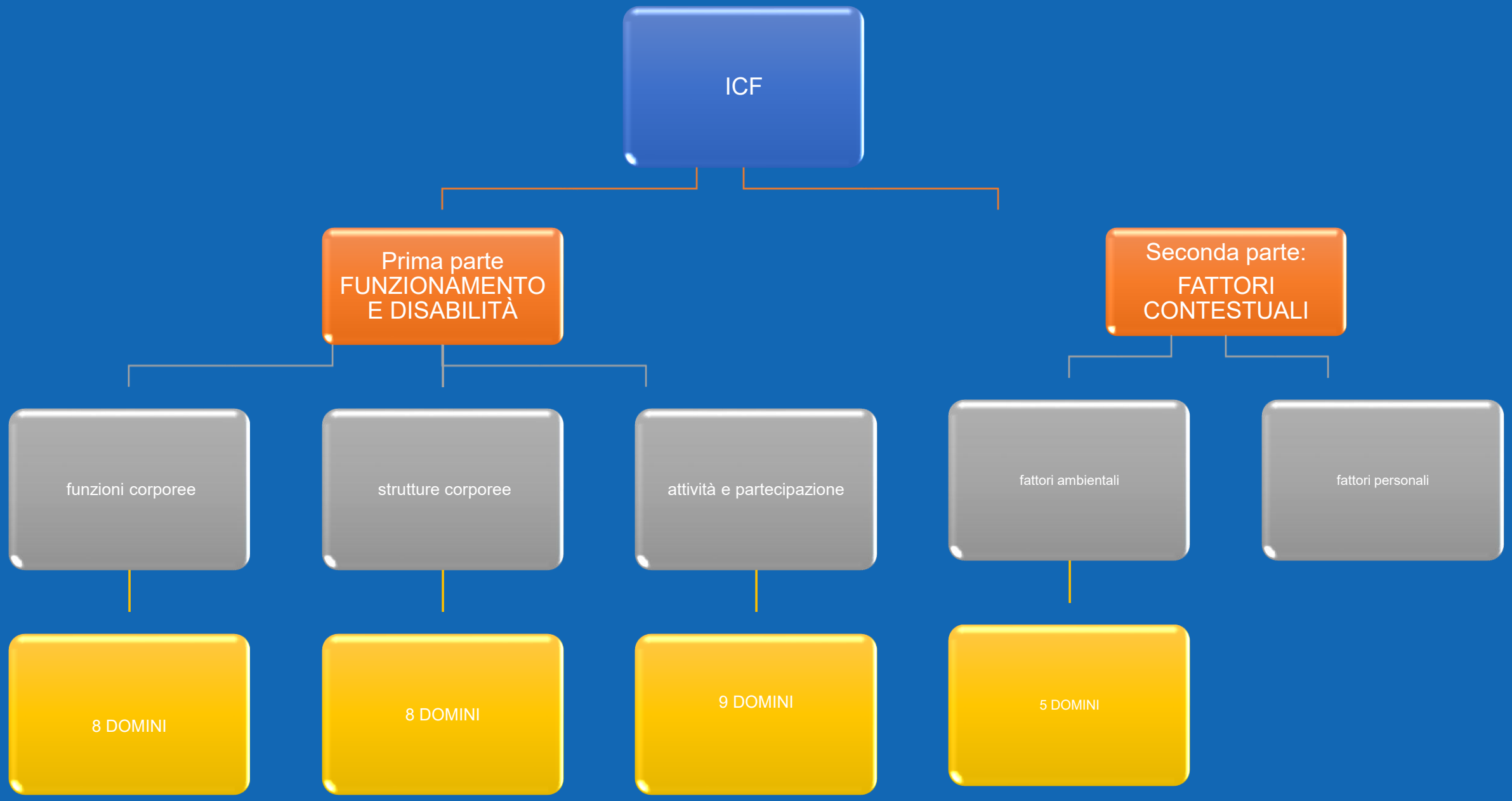
La struttura dell'ICF

L'ICF organizza le informazioni in **2 parti**, che a loro volta si dividono in **componenti** e **descrivono ogni aspetto della persona dal punto di vista biologico, psicologico e sociale.**

La struttura dell'ICF

Le componenti si dividono ulteriormente in **domini**. I domini sono insiemi di funzioni fisiologiche, strutture anatomiche, azioni, compiti o aree della vita correlate tra loro e costituiscono i diversi capitoli e i blocchi all'interno di ciascuna componente

La struttura dell'ICF



PRIMA PARTE

Componenti del Funzionamento e della Disabilità

Le funzioni corporee: sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni psicologiche)*

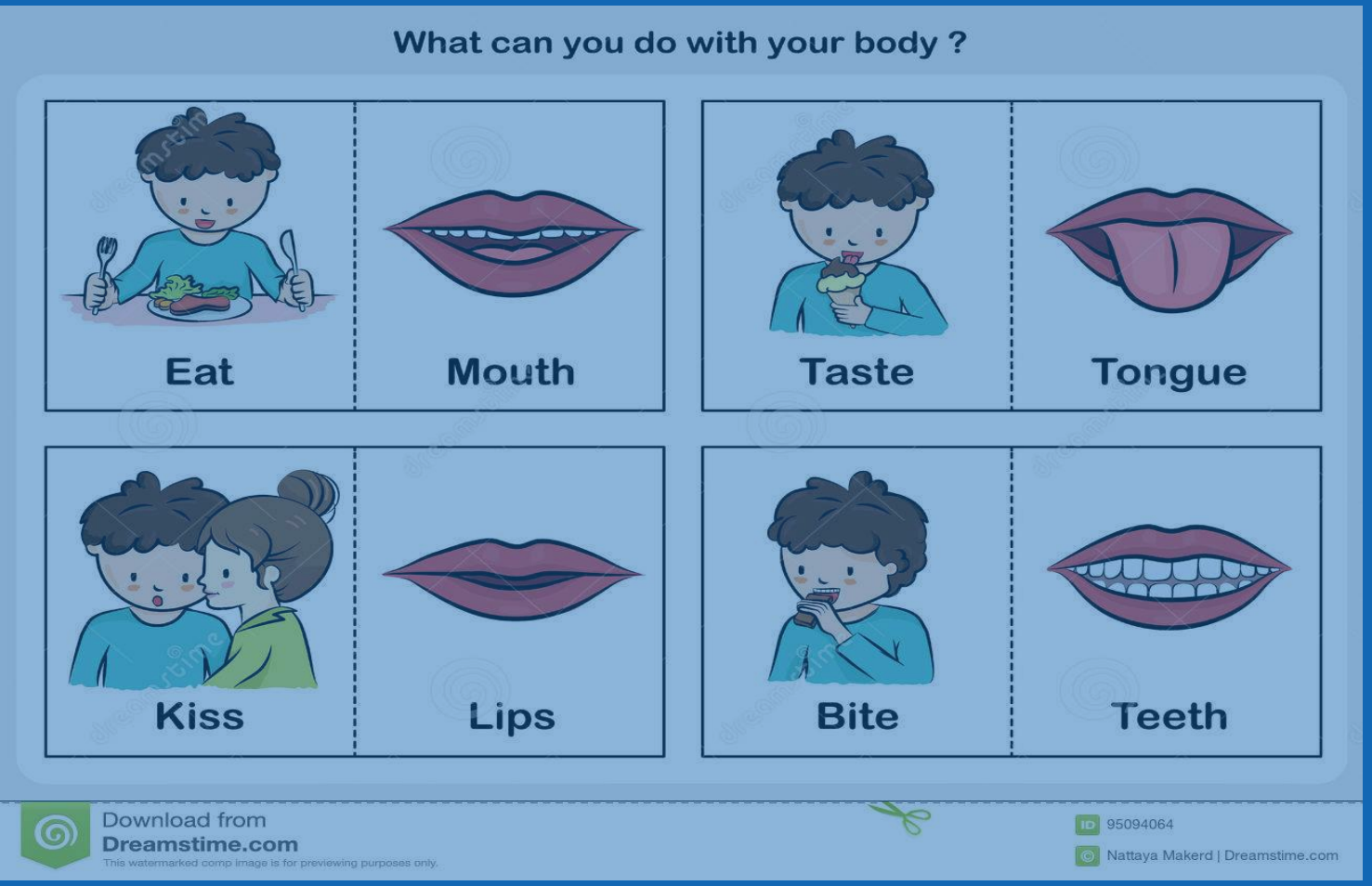
* Intro ICF

La struttura dell'ICF

Le funzioni corporee sono divise in 8 domini:

1- strutture del sistema nervoso (cervello,midollo spinale,meningi...)
2- occhio, orecchio e strutture correlate
3- strutture coinvolte nella voce e nell'eloquio (naso, bocca, faringe...)
4- strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e dell'apparato respiratorio
5- strutture correlate all'apparato digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino
6- strutture correlate ai sistemi genitourinario e riproduttivo
7- strutture correlate al movimento
8- cute e strutture correlate

La struttura dell'ICF



I verbi (es: mangiare, assaggiare, baciare, mordere) descrivono le attività/FUNZIONI delle strutture (es: bocca, lingua, labbra, denti)

PRIMA PARTE

Componenti del Funzionamento e della Disabilità

Le strutture corporee: sono le parti anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti e le loro componenti*

* Intro ICF

La struttura dell'ICF

Le strutture corporee sono divise in **8 domini:**

1- strutture del sistema nervoso (cervello,midollo spinale,meningi...)

2- occhio, orecchio e strutture correlate

3- strutture coinvolte nella voce e nell'eloquio (naso, bocca, faringe...)

4- strutture dei sistemi cardiovascolare, immunologico e dell'apparato respiratorio

5- strutture correlate all'apparato digerente e ai sistemi metabolico ed endocrino

6- strutture correlate ai sistemi genitourinario e riproduttivo

7- strutture correlate al movimento

8- cute e strutture correlate

La struttura dell'ICF

CAPITOLO 2 OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE CORRELATE

s210 [redacted] della cavità orbitaria

s220 [redacted] del bulbo oculare

s2200	Congiuntiva, sclera, coroide
s2201	Cornea
s2202	Iride
s2203	Retina
s2204	Cristallino
s2205	Corpo vitreo
s2208	Struttura del bulbo oculare, altro specificato
s2209	Struttura del bulbo oculare, non specificato

PRIMA PARTE

Componenti del Funzionamento e della Disabilità

Attività e partecipazione sono rispettivamente:

L'esecuzione di un compito o di un'azione da parte di un individuo

Il coinvolgimento in una situazione di vita*

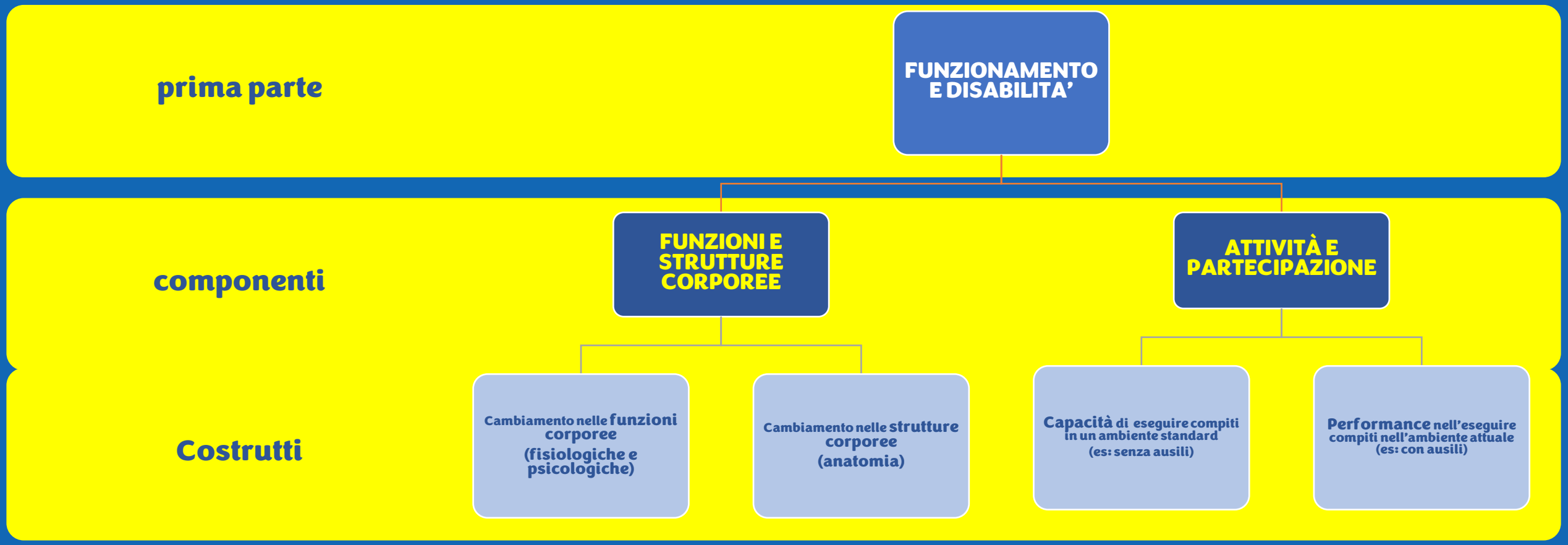
* Intro ICF

La struttura dell'ICF

Sono divise in 9 domini:

1- apprendimento e applicazione delle conoscenze (guardare,ascoltare, copiare...)
2- compiti e richieste generali (intraprendere, gestire, eseguire)
3- comunicazione (ricevere, produrre, conversare...)
4- mobilità (camminare, trasportare, cambiare mantenere posizione...)
5- cura della propria persona (lavarsi, vestirsi, mangiare...)
6- vita domestica (procurarsi i beni, svolgere compiti, prendersi cura)
7- interazioni e relazioni interpersonali (entrare in relazioni e semplici, complesse, formali, intime...)
8- aree di vita principali (istruzione, lavoro, vita economica)
9- vita sociale, civile e di comunità (ricreazione, diritti, religione)

La struttura dell'ICF



PRIMA PARTE

La struttura dell'ICF

L'insieme delle componenti descritte finora (funzioni e strutture corporee - attività e partecipazione) nella sua espressione **positiva** esprime il **funzionamento**, mentre in accezione **negativa** esprime la **disabilità.**

PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

Fattori contestuali che includono i fattori ambientali e i fattori personali

I fattori ambientali (influenze che arrivano dall'esterno) sono gli atteggiamenti, l'ambiente fisico e sociale in cui le persone vivono e conducono la loro esistenza*

* Intro ICF

La struttura dell'ICF

I fattori ambientali sono divisi in **5 domini**:

1- prodotti e tecnologia
2- ambiente naturale e cambiamenti effettuati dall'uomo
3- relazioni e sostegno sociale
4- atteggiamenti
5- servizi, sistemi e politiche

SECONDA PARTE

Fattori contestuali che includono i fattori ambientali e i fattori personali

I fattori personali (influenze che arrivano dall'interno) sono il background personale della vita e dell'esistenza dell'individuo e rappresentano quelle caratteristiche dell'individuo ... I fattori personali non sono classificati nell'ICF...*

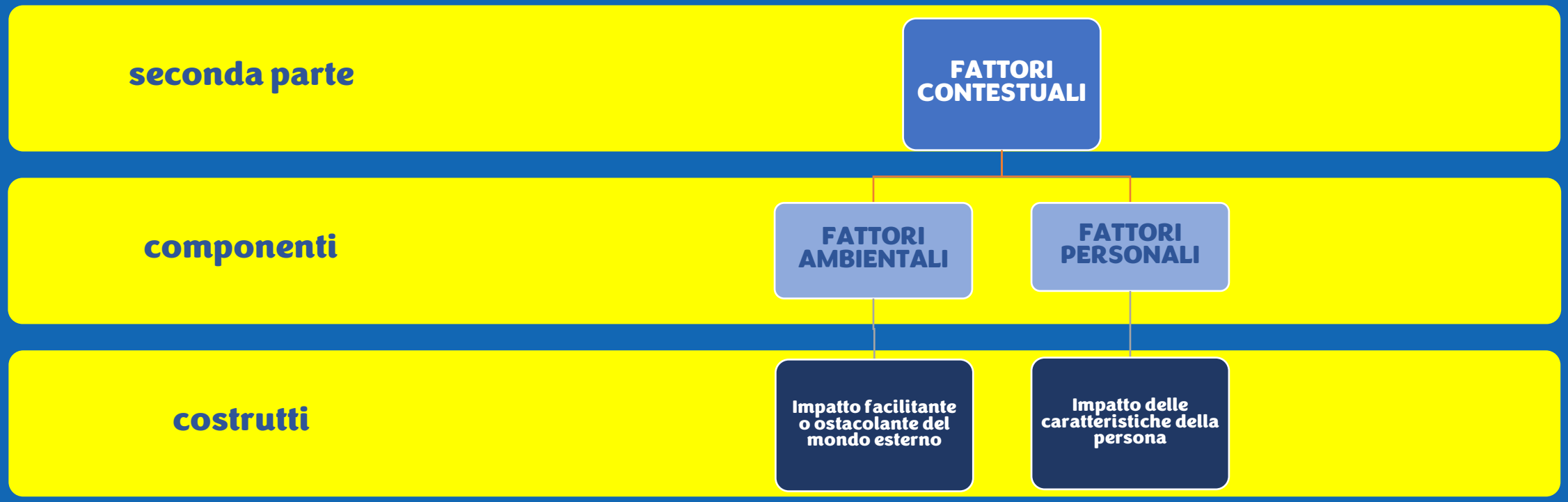
* Intro ICF

SECONDA PARTE

Possiamo considerare fattori personali:

Sesso, età, forma fisica, stile di vita, abitudini, educazione, capacità di adattamento, background sociale, istruzione, professione, esperienze, modelli, stile caratteriale...non classificabili ed elencabili a causa della loro grande varietà

La struttura dell'ICF



SECONDA PARTE

La struttura dell'ICF

L'insieme dei **fattori ambientali e personali**, cioè i fattori contestuali che interagiscono con tutte le componenti del funzionamento e della disabilità, possono avere ripercussioni positive (facilitatori) o negative (barriere)

SECONDA PARTE

La qualificazione

Questa struttura permette di assegnare un **codice alfanumerico** a ciascuna delle possibili dimensioni del funzionamento di una persona.

La codifica

le lettere indicano le componenti:

- **b (body)** le Funzioni Corporee (parte 1)
- **s (structure)** le Strutture Corporee (parte 1)
- **d (domain)** le Attività e la Partecipazione (parte 1)
- **e (enviroment)** i Fattori Ambientali (parte 2)

La codifica

Le lettere sono seguite da un codice numerico che inizia con il numero del capitolo, seguito dal secondo livello e dal terzo e quarto livello.

Sotto-componenti per livelli di progressiva specificazione.

La codifica

CAPITOLO 2 OCCHIO, ORECCHIO E STRUTTURE CORRELATE

s210 [redacted] della cavità orbitaria

s220 [redacted] del bulbo oculare

s2200	Congiuntiva, sclera, coroide
s2201	Cornea
s2202	Iride
s2203	Retina
s2204	Cristallino
s2205	Corpo vitreo
s2208	Struttura del bulbo oculare, altro specificato
s2209	Struttura del bulbo oculare, non specificato

Esempio:

s2204 cristallino.

(s2 occhio, orecchio e strutture correlate, s220 struttura del bulbo)

La codifica

b164 [illegible]cognitive di livello superiore

Funzioni mentali specifiche dipendenti in particolar modo dai lobi frontali del cervello, che includono comportamenti complessi diretti allo scopo come la capacità di prendere una decisione, il pensiero astratto, la pianificazione e la realizzazione di progetti, la flessibilità mentale e la capacità di decidere i comportamenti appropriati alle circostanze; spesso chiamate funzioni esecutive.

Inclusioni: *funzioni dell'astrazione e dell'organizzazione delle idee; gestione del tempo, insight e giudizio; formazione di concetti, categorizzazione e flessibilità cognitiva*

Esclusioni: *funzioni della memoria (b144); funzioni del pensiero (b160); funzioni mentali del linguaggio (b167); funzioni di calcolo (b172)*

b1640 Astrazione
Funzioni mentali del creare idee, qualità o caratteristiche generali a partire da, e distinte da, realtà concrete, oggetti specifici o casi effettivi.

b1641 Organizzazione e pianificazione
Funzioni mentali del coordinare le parti in un tutto unico e sistematizzarle; la funzione mentale implicata nello sviluppare un modo di procedere o di agire.

b1642 Gestione del tempo
Funzioni mentali dell'ordinare gli eventi in una sequenza cronologica, assegnando una certa quantità di tempo a eventi e attività.

b1643 Flessibilità cognitiva
Funzioni mentali del cambiare strategie, o variare inclinazioni mentali, come nella soluzione di problemi.

b1644 Insight
Funzioni mentali della consapevolezza e comprensione di se stessi e del proprio comportamento.

b1645 Giudizio
Funzioni mentali implicate nel discriminare e valutare delle diverse opzioni, come quelle coinvolte nel formarsi un'opinione.

b1646 Soluzione di problemi
Funzioni mentali dell'identificare, analizzare e integrare in una soluzione delle informazioni incongruenti o in conflitto.

b1648 Funzioni cognitive di livello superiore, altro specificato

b1649 Funzioni cognitive di livello superiore, non specificato

b167 [illegible] mentali del linguaggio

Funzioni mentali specifiche del riconoscimento e dell'utilizzo di segni, simboli e altre componenti di un linguaggio.

Inclusioni: *funzioni relative al recepire e decodificare il linguaggio verbale, scritto o in altre forme, come il linguaggio dei segni; funzioni di espressione di linguaggio verbale, scritto o in altre forme; funzioni integrative di linguaggio, orali e scritte, come quelle coinvolte nell'afasia recettiva, espressiva, di Broca, di Wernicke e di conduzione*

Esclusioni: *funzioni dell'attenzione (b140); funzioni della memoria (b144); funzioni percettive (b156); funzioni del pensiero (b160); funzioni cognitive di livello superiore (b164); funzioni di calcolo (b172); funzioni mentali di sequenza dei movimenti complessi (b176); Capitolo 2 – Funzioni sensoriali e dolore; Capitolo 3 – Funzioni della voce e dell'eloquio*

b1670 Recepire il linguaggio
Funzioni mentali specifiche della decodifica di messaggi in forma orale, scritta o altra, come il linguaggio dei segni, per ottenere il loro significato.

b16700 Recepire il linguaggio verbale
Funzioni mentali della decodifica di messaggi orali per ottenere il loro significato.

b16701 Recepire il linguaggio scritto
Funzioni mentali della decodifica di messaggi scritti per ottenere il loro significato.

b16702 Recepire il linguaggio dei segni
Funzioni mentali della decodifica di messaggi in linguaggi che utilizzano segni compiuti con le mani e altri movimenti per ottenere il loro significato.

b16703 Recepire il linguaggio gestuale
Funzioni mentali della decodifica di messaggi espressi con gesti non formalizzati fatti con le mani e con altri movimenti per ricavarne il significato.

b16708 Recepire il linguaggio, altro specificato

b16709 Recepire il linguaggio, non specificato

b1671 Espressione del linguaggio
Funzioni mentali specifiche necessarie per produrre messaggi significativi in forma orale, scritta, mediante il linguaggio dei segni o altre forme di linguaggio.

b16710 Espressione del linguaggio verbale
Funzioni mentali necessarie per produrre messaggi verbali significativi.

b16711 Espressione del linguaggio scritto
Funzioni mentali necessarie per produrre messaggi scritti significativi.

b16712 Espressione del linguaggio dei segni
Funzioni mentali necessarie per produrre messaggi significativi in linguaggi che utilizzano segni compiuti con le mani e altri movimenti.

b16713 Espressione del linguaggio gestuale
Funzioni mentali necessarie per produrre messaggi mediante gesti non formalizzati fatti con le mani e con altri movimenti.

b16718 Espressione del linguaggio, altro specificato

b16719 Espressione del linguaggio, non specificato

b1672 Funzioni linguistiche integrative
Funzioni mentali che organizzano significato semantico e simbolico, struttura grammaticale e idee, per la produzione di messaggi in forma verbale, scritta o altre forme di linguaggio.

b1678 Funzioni mentali del linguaggio, altro specificato

b1679 Funzioni mentali del linguaggio, non specificato

b172 [illegible]oni di calcolo

Funzioni mentali specifiche di determinazione, approssimazione e utilizzo di simboli e processi matematici.

La qualificazione

La codifica in sé non assume significato se priva di una valutazione che esprima il grado di difficoltà che quella persona manifesta in uno specifico ambito del suo stato di salute e all'interno di una particolare interazione con l'ambiente in cui vive.

- .

La qualificazione

A ciascun codice si associa un **qualificatore** in base alla **valutazione** dello stato di salute di una persona da parte di un operatore (sanitario, sociale, educativo ...).

La qualificazione

I costrutti assumono significato, utilizzando i **qualificatori** che offrono un valutazione

Sono **codici numerici** :

- che specificano **l'estensione o la gravità del funzionamento o della disabilità**
- che indicano il grado in cui un fattore ambientale rappresenta un **facilitatore (+) o una barriera.**

COMPONENTE ICF	QUALIFICATORI		
b-Funzioni corporee	1 qualificatore	bxxx.Q	Gravità della menomazione
S-Strutture corporee	primo qualificatore	sxxx.Q_ _	Gravità della menomazione
	Secondo qualficatore	sxxx._Q_	Natura della menomazione
	Terzo qualificatore	sxxx._ _ Q	Localizzazione della menomazione
d-Attività e partecipazione	Primo qualificatore	dxxx.Q_	Performance
	Secondo qualificatore	dxxx._Q	Capacità
e-Fattori ambientali	1 qualificatore	exxx. Q/-	Barierra o facilitatore

Esempio

ESEMPIO DI PROFILO DI FUNZIONAMENTO*

Nome …. Nato il……

DIAGNOSI CLINICA : Quadro di disturbo pervasivo dello sviluppo e ritardo cognitivo.

1 Autismo Atipico ICD 10 **F84.1**

2 Ritardo Mentale Moderato ICD 10 **F 71**

FUNZIONI CORPOREE

Recentemente è stato sottoposto a test di intelligenza non verbale (scala Leiter-R) al quale ha ottenuto un Q.I. globale di 50. (b117.3)

Presenta spesso fobie (b160.3) riferite ad alcuni oggetti di uso comune che si esprimono con modalità bizzarre.

Ha importanti difficoltà nel riconoscimento dei segnali “sociali” (b122.3) non verbali, presenta inoltre un ritardo del linguaggio di grado elevato (b167.3) e un discreto impaccio psico-motorio sia fine che grossolano (b147.2), episodicamente e collegati a momenti di tensione stereotipie e tic complessi (b765.1).

*Fusaro – glossario DGR34- bozza 2 –Aug 2012

Esempio

ATTIVITA' E PARTECIPAZIONE

Scrive, in modo chiaro e ordinato, semplici frasi solo in stampato maiuscolo (d170.333).
Legge semplici frasi solo se supportato dagli insegnanti e attraverso riviste accattivanti che abbiano belle immagini (d166.344 e330+3, e130+3).
La schematizzazione e la strutturazione per punti facilitano l'apprendimento di semplici argomenti (d159.334 e130+3).
Nell'ambito della gestione della routine quotidiana fatica molto a tollerare le piccole frustrazioni e a contenere l'ansia che ne deriva. E' necessario prepararlo prima, da parte di una figura di mediazione, ad eventuali cambiamenti (spostamenti di banco, assenze di insegnanti, feste scolastiche, visite a parenti, etc); a tal riguardo si è rivelato utile l'utilizzo di agende "visive". E' tuttavia in grado di prepararsi lo zaino autonomamente (d230.344 e3+3, e125+).
In situazioni per lui fonte di tensione, si nota la comparsa di importanti rituali ossessivi e, a volte, di tic complessi (d240.444).
Presenta episodicamente atteggiamenti di tipo oppositivo nei confronti delle richieste di prestazioni da parte degli adulti (d298.111).
Nel parlare, non riesce a strutturare in maniera adeguata la frase e utilizza spesso per comunicare espressioni e frasi non sempre adeguati al contesto con qualche miglioramento grazie ai costanti stimoli che gli vengono forniti da insegnanti e famiglia (d330.333 e310+3, e330+3); comprende sia messaggi orali (d310.333) che scritti (d325.333), purché brevi e preferibilmente riferiti alla quotidianità. Predilige messaggi mimico-gestuali con cui riesce a farsi comprendere da conoscenti e famigliari (d335.000).

La qualificazione

Dalla qualificazione potrebbe seguire:

- una **menomazione** (funzioni, strutture del **corpo**)
- una **limitazione** (nell'eseguire un'**attività**)
- una **restrizione** (partecipazione, coinvolgimento)
- una **barriera** (fattori **contestuali**)

La qualificazione

Un **facilitatore** è un fattore ambientale in grado di modificare in termini positivi il funzionamento della persona in una specifica attività.

È un fattore che mediante la sua presenza **migliora il funzionamento e riduce la disabilità**, puo' evitare che una menomazione o una limitazione diventino una restrizione della partecipazione

La qualificazione

Una **barriera** è un fattore nell'ambiente di un individuo che limita il suo funzionamento e crea o amplifica la disabilità.

È un fattore che mediante la sua presenza **limita il funzionamento e crea disabilità**, è un ostacolo all'attività e alla partecipazione

La qualificazione

Attività e partecipazione sono osservate nei vari contesti di vita e poi qualificate distintamente in **PERFORMANCE** (osservazione in ambiente attuale, magari adattato) o **CAPACITÀ** (osservazione in ambiente standard).

La qualificazione

La **performance** è ciò che una persona effettivamente fa. La performance descrive quello che l'individuo fa **nel suo ambiente** attuale e reale. Tramite essa, è possibile valutare il grado di difficoltà incontrato dalla persona nello svolgere attività e azioni di partecipazione alla vita sociale nei suoi contesti di vita abituali **con i sostegni in atto**.

La **capacità** è ciò che una persona può fare ed è una caratteristica intrinseca di quella persona. Essa quindi è indipendente dall'ambiente e descrive il funzionamento della persona in un **ambiente neutro che non facilita e non ostacola**

Per le funzioni corporee c'è un qualificatore che esprime la gravità della menomazione

FUNZIONI CORPOREE	SIGNIFICATO DEL Q
bxxx.0	nessun problema (assente)
bxxx.1	problema lieve (leggero)
bxxx.2	problema medio (moderato)
bxxx.3	problema grave (elevato)
bxxx.4	problema completo (totale)
bxxx.8	non sppecificato
bxxx.9	non applicabile

STRUTTURE CORPOREE		SIGNIFICATO DEL Q
ESTENSIONE DEL PROBLEMA	sxxx.0_ _ sxxx.1_ _ sxxx.2_ _ sxxx.3_ _ sxxx.4_ _ sxxx.8_ _ sxxx.9_ _	nessun problema problema lieve problema medio problema grave problema completo non sppecificato non applicabile
NATURA DEL CAMBIAMENTO	sxxx._0_ sxxx._1_ sxxx._2_ sxxx._3_ sxxx._4_	nessun cambiamento nella S. assenza totale assenza parziale parte in eccesso dimensioni anormali
NATURA DEL CAMBIAMENTO	**sxxx._5_** **sxxx._6_** **sxxx._7_** **sxxx._8_** **sxxx._9_**	**discontinuità** **posizione deviante** **cambiamenti qualitativi nella** **struttura non specificato** **non applicabile**
LOCALIZZAZIONE DEL PROBLEMA	sxxx._ _0 sxxx._ _1 sxxx._ _2 sxxx._ _3 sxxx._ _4 sxxx._ _5 sxxx._ _6 sxxx._ _7 sxxx._ _8 sxxx._ _9	piu' di una regione destra sinistra entrambi i lati frontale dorsale Prossimale distale non specificato non applicabile

Per le strutture corporee ci sono tre qualificatori, che definiscono: l'estensione, la natura e la localizzazione della menomazione

Per le attività e la partecipazione i qualificatori sono: capacità e performance

ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE		SIGNIFICATO DEL Q
PERFORMANCE	dxxx.0_ dxxx.1_ dxxx.2_ dxxx.3_ dxxx.4_ dxxx.8_ dxxx.9_	nessuna difficoltà difficoltà lieve difficoltà media difficoltà grave difficoltà complet a non sppecificato non applicabile
CAPACITÀ	dxxx._ 0 dxxx._ 1 dxxx._ 2 dxxx._ 3 dxxx._ 4 dxxx._ 8 dxxx._ 9	nessuna difficoltà difficoltà lieve difficoltà media difficoltà grave difficoltà complet a non sppecificato non applicabile

FATTORI AMBIENTALI		SIGNIFICATO DEL Q
BARRIERA	exxx.0 exxx.1 exxx.2 exxx.3 exxx.4 exxx.8 exxx.9	nessuna barriera barriera lieve barriera media barriera grave barriera completa barriera non specificata non applicabile
FACILITATORE	exxx+0 exxx+1 exxx+2 exxx+3 exxx+4 exxx+8 exxx.9	nessun facilitatore facilitatore lieve facilitatore medio facilitatore sostanziale facilitatore completo facilitatore non specificato non applicabile

Per i fattori ambientali i qualificatori sono: barriera o facilitatore

La qualificazione

TABELLA 1
Interrelazione dinamica delle componenti

	Parte 1: Funzionamento e disabilità		Parte 2: Fattori contestuali	
Componenti	**Funzioni e Strutture Corporee**	**Attività e Partecipazione**	**Fattori Ambientali**	**Fattori Personali**
Domini	Funzioni Corporee Strutture Corporee	Aree di vita (compiti, azioni)	Influenze esterne su funzionamento e disabilità	Influenze interne su funzionamento e disabilità
Costrutti	Cambiamento nelle funzioni corporee (fisiologico) Cambiamento nelle strutture corporee (anatomico)	Capacità: eseguire compiti in un ambiente standard Performance: eseguire compiti nell'ambiente attuale	Impatto facilitante o ostacolante delle caratteristiche del mondo fisico, sociale e degli atteggiamenti	Impatto delle caratteristiche della persona
Aspetto positivo	Integrità funzionale e strutturale	Attività Partecipazione	Facilitatori	Facilitatori
	Funzionamento			
Aspetto negativo	Menomazione	Limitazione dell'attività Restrizione della partecipazione	Barriere/ostacoli	Barriere/ostacoli
	Disabilità			

Disabilità è un termine ombrello per menomazioni delle funzioni e delle strutture corporee,
limitazioni delle attività o restrizione della partecipazione

La qualificazione nel nostro lavoro può servire per la progettazione del PEI …

… interventi che, a partire dalla condizione complessiva di vita di una singola persona, tendano a:

- ridurre l'impatto delle difficoltà di una persona sui suoi livelli di partecipazione sociale;
- potenziare le sue risorse e ad utilizzare le sue capacità;
- individuare in che modo le barriere ambientali, sociali e psicologiche la condizionano;
- ricercare strumenti e tecniche per lo svolgimento del PEI.

PER CONCLUDERE…

…noi siamo parte e siamo responsabili dell'ambiente, lasciamo il segno per come siamo e come agiamo.

BIBLIOGRAFIA :

Ianes D (2004), La diagnosi funzionale secondo l'ICF, Erickson

OMS (2001), Classificazione internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF), Erickson

Check List – Versione Breve PDF- who.int

check list salvare su i corsi